

Scenario 1:

Una donna di 27 anni, asintomatica, in buone condizioni di salute, due gravidanze a termine, con un'anamnesi patologica completamente muta e con una sorella affetta da lupus eritematoso sistemico, esegue su consiglio del medico curante uno screening di laboratorio per autoanticorpi. Viene riscontrata positività per gli anticorpi anti-nucleo con titolo 1:160 e per le IgM anti-cardiolipina (con LLAC e anti-beta2 glicoproteina I negativi).

Domanda 1: (codice domanda: ssm20171) - (riferita allo scenario n.1):

Qual è la condotta più corretta in questo caso?

- ☒ A: Non vi è indicazione all'avvio immediato di alcuna terapia
- ☐ B: Avviare terapia con clopidogrel
- ☐ C: Avviare terapia con warfarin
- ☐ D: Avviare terapia con eparina a basso peso molecolare a dosaggio profilattico
- ☐ E: Avviare terapia con prednisone a basse dosi

Domanda 2: (codice domanda: ssm20173) :

Con quale termine si definisce la presenza di cellule o tessuti microscopicamente normali ma situati in sede anomala?

- ☒ A: Coristoma
- ☐ B: Amartoma
- ☐ C: Differenziazione anomala
- ☐ D: Tiloma
- ☐ E: Cordoma

Domanda 3: (codice domanda: ssm20174) :

Quale delle seguenti è una traslocazione tipicamente associata al sarcoma di Ewing?

- ☒ A: t(11;22)
- ☐ B: t(14;18)
- ☐ C: t(8;14)
- ☐ D: t(9;22)
- ☐ E: t(11;18)

Scenario 2:

Una donna di 35 anni, nullipara, si reca dal proprio ginecologo per eseguire un PAP-test di routine. All'atto del prelievo è asintomatica.

Domanda 4: (codice domanda: ssm20175) - (riferita allo scenario n.2):

Quale infezione è correlata alla patologia neoplastica della cervice uterina?

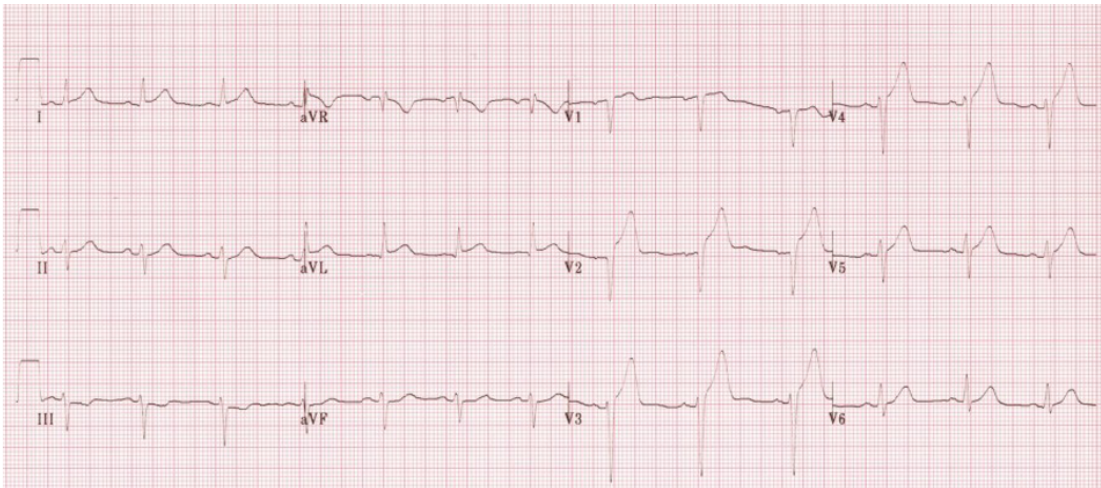
- ☒ A: HPV
- ☐ B: HIV
- ☐ C: Neisseria gonorrhoeae
- ☐ D: HSV-1
- ☐ E: HSV-2

Domanda 5: (codice domanda: ssm20176) - (riferita allo scenario n.2):

Come viene standardizzata attualmente la lettura del PAP-test?

- ☒ A: Sistema di Bethesda
- ☐ B: Sistema di Papanicolaou
- ☐ C: Linee guida di Tokio
- ☐ D: Criteri di Glasgow
- ☐ E: Livelli di Berg

Scenario 3:



Domanda 6: (codice domanda: ssm201711) - (riferita allo scenario n.3):

L'immagine mostra un tracciato elettrocardiografico corrispondente a:

- ☒ A: Infarto miocardico della parete anteriore
- ☐ B: Fibrillazione atriale
- ☐ C: Infarto miocardico della parete posteriore
- ☐ D: Infarto miocardico della parete inferiore
- ☐ E: Blocco atrioventricolare di terzo grado

Domanda 7: (codice domanda: ssm201712) - (riferita allo scenario n.3):

Il paziente presenterà probabilmente:

- ☒ A: occlusione della discendente anteriore
- ☐ B: occlusione della circonflessa
- ☐ C: occlusione della discendente posteriore
- ☐ D: sintomi da attivazione vagale
- ☐ E: pneumotorace

Scenario 4:

Un paziente di 75 anni deve essere sottoposto a un intervento elettivo di resezione intestinale. In anamnesi presenta una fibrillazione atriale cronica in terapia con warfarin.

Domanda 8: (codice domanda: ssm201713) - (riferita allo scenario n.4):

Secondo le attuali linee guida europee, in vista dell'intervento:

- ☒ A: bisognerà sospendere l'anticoagulante 5 giorni prima dell'intervento
- ☐ B: l'anticoagulante va sospeso 24 ore prima dell'intervento
- ☐ C: non bisogna modificare la terapia a causa dell'elevato rischio cardiologico
- ☐ D: bisognerà aggiungere al warfarin un farmaco antiaggregante per il rischio cardiologico legato all'intervento
- ☐ E: bisogna eseguire un ECG per verificare che sia ancora in fibrillazione atriale

Domanda 9: (codice domanda: ssm201714) - (riferita allo scenario n.4):

L'ecocardiografia preoperatoria mostra una funzione contrattile moderatamente depressa. A quale di questi valori di FE (frazione di eiezione) può corrispondere?

- ☒ A: FE 40%
- ☐ B: FE 62%
- ☐ C: FE 75%
- ☐ D: FE 25%
- ☐ E: FE 56%

Scenario 5:

Una ragazza di 15 anni si presenta in Pronto Soccorso perché da un'ora ha difficoltà respiratoria, frequenza respiratoria 35 atti/min e all'auscultazione apprezzate fischi e sibili.

Domanda 10: (codice domanda: ssm201715) - (riferita allo scenario n.5):

Raccogliendo l'anamnesi quale informazione clinica più probabilmente emergerà?

- ☒ A: Asma allergico
- ☐ B: Tubercolosi
- ☐ C: Nascita prematura
- ☐ D: Fibrosi cistica
- ☐ E: Prolasso mitralico

Domanda 11: (codice domanda: ssm201716) - (riferita allo scenario n.5):

In considerazione del quadro clinico, si chiede che vengano eseguiti prioritariamente:

- ☒ A: emogasanalisi arteriosa e RX torace
- ☐ B: ecocardiogramma e RX torace
- ☐ C: emogasanalisi arteriosa e TC torace
- ☐ D: TC torace e spirometria
- ☐ E: prick test e spirometria

Domanda 12: (codice domanda: ssm201717) - (riferita allo scenario n.5):

Quale dei seguenti farmaci NON è da utilizzare per trattare questa paziente?

- ☒ A: Protossido d'azoto
- ☐ B: Ossigeno
- ☐ C: Magnesio solfato
- ☐ D: Corticosteroidi
- ☐ E: Beta2 agonista

Scenario 6:

Viene ricoverato in rianimazione un uomo di 54 anni con diagnosi di shock settico a partenza dalle vie urinarie.

Domanda 13: (codice domanda: ssm201718) - (riferita allo scenario n.6):

Dovendo sostenerlo dal punto di vista emodinamico, quale dei seguenti farmaci è opportuno somministrare?

- ☒ A: Noradrenalina
- ☐ B: Dobutamina
- ☐ C: Desmopressina
- ☐ D: Aminofillina
- ☐ E: Dopamina

Domanda 14: (codice domanda: ssm201719) - (riferita allo scenario n.6):

Il supporto emodinamico con le amine serve a:

- ☒ A: migliorare la perfusione d'organo
- ☐ B: garantire una PVC >12 cm H₂O
- ☐ C: prevenire il tromboembolismo
- ☐ D: ottimizzare la sedazione
- ☐ E: garantire una diuresi di 2.500 ml die

Scenario 7:

Una donna di 25 anni lamenta dispnea da sforzo. Agli esami ematochimici gli indici di flogosi sono negativi. All'ecocardiogramma si evidenzia un prolasso della mitrale da rottura di corda tendinea. Secondo le linee guida la paziente viene sottoposta a intervento di plastica della mitrale. Dopo l'intervento è in ritmo sinusale.

Domanda 15: (codice domanda: ssm201728) - (riferita allo scenario n.7):

Quale terapia è indicata alla dimissione?

- ☒ A: Terapia anticoagulante orale per i primi 3-6 mesi, seguita da terapia antiaggregante piastrinica
- ☐ B: Terapia anticoagulante orale per i primi 9-12 mesi, seguita da terapia antiaggregante piastrinica
- ☐ C: Terapia anticoagulante orale per tutta la vita
- ☐ D: Terapia anticoagulante orale per i primi 6 mesi ma non seguita da terapia antiaggregante piastrinica
- ☐ E: Terapia antiaggregante per i primi 12 mesi

Domanda 16: (codice domanda: ssm201730) :

In caso di ischemia mesenterica acuta di origine embolica, qual è l'approccio terapeutico più opportuno tra i seguenti?

- ☒ A: Intervento chirurgico urgente
- ☐ B: Intervento chirurgico in elezione
- ☐ C: Terapia cortisonica
- ☐ D: Terapia antibiotica ad ampio spettro
- ☐ E: Digiuno e terapia di supporto

Scenario 8:

Un giovane di 23 anni, sportivo e modesto fumatore (5 sigarette/die da 5 anni), lamenta un dolore trafittivo all'emitorace sinistro, improvviso e violento.

Domanda 17: (codice domanda: ssm201731) - (riferita allo scenario n.8):

Quale altro sintomo associato deve essere ricercato?

- ☒ A: Dispnea
- ☐ B: Emoftoe
- ☐ C: Disfonia
- ☐ D: Tosse produttiva
- ☐ E: Disfagia

Domanda 18: (codice domanda: ssm201732) - (riferita allo scenario n.8):

Qual è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Pneumotorace
- ☐ B: Infarto miocardico
- ☐ C: Polmonite lobare
- ☐ D: Infarto polmonare
- ☐ E: Reflusso gastroesofageo

Domanda 19: (codice domanda: ssm201733) - (riferita allo scenario n.8):

Quale esame deve essere eseguito in prima istanza?

- ☒ A: Radiografia del torace
- ☐ B: Ecocolordoppler cardiaco
- ☐ C: TC torace
- ☐ D: Radiografia dell'emicostato sinistro
- ☐ E: Spirometria

Scenario 9:

Un paziente esegue una TC del torace che dimostra un nodulo subpleurico del lobo superiore sinistro a margini spiccati di diametro 1,8 cm.

Domanda 20: (codice domanda: ssm201734) - (riferita allo scenario n.9):

Nel sospetto di neoplasia polmonare, quale tra i seguenti è l'esame diagnostico più appropriato per la stadiazione della malattia, in funzione della pianificazione della strategia terapeutica?

- ☒ A: PET-TC total body
- ☐ B: RM toracica
- ☐ C: Broncoscopia
- ☐ D: TC addome con mezzo di contrasto
- ☐ E: Scintigrafia polmonare

Domanda 21: (codice domanda: ssm201735) - (riferita allo scenario n.9):

In considerazione della sede della lesione, quale esame è indicato in prima istanza per la tipizzazione cito-istologica?

- ☒ A: Agobiopsia TC guidata
- ☐ B: Broncoscopia con biopsia
- ☐ C: Broncoscopia con brushing endobronchiale
- ☐ D: Toracentesi ed esame citologico
- ☐ E: Esame citologico dell'escreato

Domanda 22: (codice domanda: ssm201736) - (riferita allo scenario n.9):

Quali dei seguenti farmaci devono essere sospesi o sostituiti prima delle procedure diagnostiche invasive?

- ☒ A: Anticoagulanti orali
- ☐ B: Antidepressivi triciclici
- ☐ C: Anti-ipertensivi
- ☐ D: Antidiabetici orali
- ☐ E: FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei)

Scenario 10:

Un paziente di 54 anni lamenta da 3 mesi violento dolore anale, scatenato dalla defecazione, ma perdurante per diverse ore. A volte ha proctorragie di modesta entità.

Domanda 23: (codice domanda: ssm201737) - (riferita allo scenario n.10):

Sulla base della raccolta dei dati anamnestici, quale diagnosi è più probabile?

- ☒ A: Ragade anale
- ☐ B: Ascesso perianale
- ☐ C: Condilomatosi
- ☐ D: Trombosi emorroidaria
- ☐ E: Emorroidi

Domanda 24: (codice domanda: ssm201738) - (riferita allo scenario n.10):

A quale esame deve essere sottoposto il paziente in prima istanza per confermare il sospetto diagnostico?

- ☒ A: Esplorazione digitale del retto e anoscopia
- ☐ B: Manometria ano-rettale
- ☐ C: Ecografia trans-anale
- ☐ D: RX clisma opaco
- ☐ E: Defecografia

Domanda 25: (codice domanda: ssm201739) - (riferita allo scenario n.10):

Per escludere la presenza di altre patologie che possano causare proctorragie, anche in considerazione dell'età del paziente, è inoltre opportuno sottoporlo in prima istanza a:

- ☒ A: rettocolonscopia
- ☐ B: rettoscopia
- ☐ C: ecografia addominale
- ☐ D: RX addome
- ☐ E: TC addome

Scenario 11:

A un paziente di 65 anni, in buone condizioni generali, con funzionalità respiratoria e cardiologica conservata, viene diagnosticata una neoplasia del lobo polmonare superiore sinistro.

Domanda 26: (codice domanda: ssm201740) - (riferita allo scenario n.11):

Al termine della stadiazione risulta essere un carcinoma a piccole cellule T2, N1, M0. Che terapia verrà proposta al paziente?

- ☒ A: Chemioterapia
- ☐ B: Resezione chirurgica con linfadenectomia ilo-mediastinica
- ☐ C: Resezione chirurgica senza linfadenectomia ilo-mediastinica
- ☐ D: Radioterapia
- ☐ E: Chemioterapia eventualmente seguita da ormonoterapia

Scenario 12:

Per un neonato di 3 giorni con ritardata emissione di meconio, distensione addominale e vomito biliare, il chirurgo pediatra pone il sospetto di Morbo di Hirschsprung.

Domanda 27: (codice domanda: ssm201751) - (riferita allo scenario n.12):

L'RX addome mostra delle anse intestinali dilatate. Quale successivo esame diagnostico strumentale è opportuno eseguire per corroborare il sospetto di megacolon congenito?

- ☒ A: Clisma opaco con mezzo di contrasto idrosolubile
- ☐ B: TC addome con mezzo di contrasto
- ☐ C: TC addome senza mezzo di contrasto
- ☐ D: Ecografia addome completo
- ☐ E: RM dell'addome inferiore con mezzo di contrasto

Domanda 28: (codice domanda: ssm201753) :

Quali sono, in ordine cronologico, le fasi fisiopatologiche della malattia da ustione?

- ☒ A: 1) fase di shock; 2) fase tossinfettiva; 3) fase distrofico-cicatriziale
- ☐ B: 1) fase tossinfettiva; 2) fase di shock; 3) fase distrofico-cicatriziale
- ☐ C: 1) fase tossinfettiva; 2) fase distrofico-cicatriziale; 3) fase di shock
- ☐ D: 1) fase di shock; 2) fase distrofico-cicatriziale; 3) fase tossinfettiva
- ☐ E: 1) fase distrofico-cicatriziale; 2) fase di shock

Scenario 13:

Un paziente di 82 anni presenta versamento pleurico monolaterale recidivante. In anamnesi è segnalata esposizione lavorativa all'amianto per diversi anni. Non sono note altre patologie croniche e non assume terapia domiciliare.

Domanda 29: (codice domanda: ssm201755) - (riferita allo scenario n.13):

Nel sospetto di mesotelioma pleurico, qual è l'accertamento che permette di formulare una diagnosi definitiva?

- ☒ A: Biopsia pleurica toracoscopica o a cielo aperto
- ☐ B: TC con mezzo di contrasto
- ☐ C: RM torace
- ☐ D: RX torace
- ☐ E: Ecografia polmonare

Scenario 14:

Una donna di 70 anni, affetta da arteriopatia cronica obliterante degli arti inferiori, giunge in ambulatorio per dolore a riposo da circa 3 settimane scarsamente responsivo agli antidolorifici. Non presenta lesioni trofiche.

Domanda 30: (codice domanda: ssm201757) - (riferita allo scenario n.14):

A quale stadio, secondo la classificazione di Leriche Fontaine, sono riconducibili i sintomi della paziente?

- ☒ A: III
- ☐ B: I
- ☐ C: II
- ☐ D: IV
- ☐ E: II B

Scenario 15:



Paziente uomo di 85 anni, pregresso ictus ischemico, diabetico, in terapia polifarmacologica. Da circa un mese comparsa di placche eritematose orticarioidi diffuse con successiva comparsa di bolle tese a contenuto limpido. Le lesioni sono intensamente pruriginose.

Domanda 31: (codice domanda: ssm201760) - (riferita allo scenario n.15):

Qual è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Pemfigoide bolloso
- ☐ B: Pemfigo volgare
- ☐ C: Herpes Zoster
- ☐ D: Impetigine bollosa
- ☐ E: Dermatite da contatto

Domanda 32: (codice domanda: ssm201761) - (riferita allo scenario n.15):

Qual è il procedimento diagnostico più appropriato?

- ☒ A: Biopsia cutanea per istologia e immunofluorescenza diretta, ricerca degli anticorpi anti-membrana basale
- ☐ B: Ricerca di anticorpi circolanti anti gliadina e antitransglutaminasi IgA ed IgG
- ☐ C: Esame citodiagnostico di Tzank da contenuto della bolla
- ☐ D: Dermatoscopia della bolla dopo rimozione del tetto
- ☐ E: Biopsia cutanea per istologia e immunofluorescenza diretta, ricerca degli anticorpi anti-desmogleina 1 e anti-desmogleina 3

Scenario 16:

Un uomo di 69 anni giunge all'attenzione dell'ematologo per il riscontro all'elettroforesi sieroproteica di una banda omogenea in zona Beta2. L'immunofissazione sierica conferma la presenza di una componente monoclonale.

Domanda 33: (codice domanda: ssm201764) - (riferita allo scenario n.16):

Quale tra le seguenti patologie può essere sicuramente esclusa, alla luce di tali reperti?

- ☒ A: Immunodeficienza comune variabile
- ☐ B: Plasmocitoma solitario dell'osso
- ☐ C: Amiloidosi primitiva
- ☐ D: Macroglobulinemia di Waldenstrom
- ☐ E: MGUS

Domanda 34: (codice domanda: ssm201765) - (riferita allo scenario n.16):

Quale tra le seguenti situazioni rientra nella definizione di mieloma multiplo asintomatico?

- ☒ A: 12% di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare e assenza di CRAB (ipercalcemia, insufficienza renale, anemia e lesioni osteolitiche)
- ☐ B: 5% di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare e iperparatiroidismo
- ☐ C: 65% di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare e assenza di CRAB (ipercalcemia, insufficienza renale, anemia e lesioni osteolitiche)
- ☐ D: 8% di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare e componente monoclonale inferiore al 30% all'elettroforesi sieroproteica
- ☐ E: 20% di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare e presenza di CRAB (ipercalcemia, insufficienza renale, anemia e lesioni osteolitiche)

Domanda 35: (codice domanda: ssm201766) - (riferita allo scenario n.16):

Quale tra le seguenti combinazioni predice una minore sopravvivenza nei pazienti affetti da mieloma multiplo?

- ☒ A: Elevata concentrazione di beta-2 microglobulina sierica e presenza della traslocazione cromosomica t(4;14)
- ☐ B: Elevata concentrazione plasmatica di gammaglobuline monoclonali e presenza di osteolisi
- ☐ C: Elevata concentrazione di catene leggere urinarie e anemia
- ☐ D: Ridotta clearance della creatinina e proteinuria di Bence-Jones
- ☐ E: Presenza di plasmacellule monoclonali alla biopsia osteomidollare superiore al 50% e anemia

Scenario 17:

Un ragazzo di 14 anni giunge in Pronto Soccorso accompagnato dalla madre per importante addominalgia, tachipnea e compromissione del sensorio. Non vi sono segni di rigor nucale. La glicemia capillare è 405 mg/dL, corpi chetonici nelle urine; emogasanalisi: acidosi metabolica. Gli indici di flogosi sono negativi.

Domanda 36: (codice domanda: ssm201771) - (riferita allo scenario n.17):

Quale approccio terapeutico è indicato in questa circostanza?

- ☒ A: Somministrazione di insulina rapida per via endovenosa
- ☐ B: Somministrazione di insulina lenta per via sottocutanea
- ☐ C: Solo idratazione e somministrazione di bicarbonati
- ☐ D: Ipoglicemizzanti orali
- ☐ E: Dieta priva di zuccheri

Domanda 37: (codice domanda: ssm201772) - (riferita allo scenario n.17):

Si conduce una raccolta anamnestica degli ultimi giorni prima del ricovero con l'ausilio della madre. Quale dei seguenti elementi NON è tipicamente associato al quadro che si sospetta alla luce dei dati clinici e biochimici a disposizione?

- ☒ A: Diarrea
- ☐ B: Polidipsia
- ☐ C: Poliuria
- ☐ D: Calo ponderale
- ☐ E: Vomito

Scenario 18:

Un paziente di 78 anni affetto da carcinoma prostatico si presenta in Pronto Soccorso per dolore al rachide. Si riscontrano livelli di calcemia di 12.0 mg/dL (vn 8.5-10).

Domanda 38: (codice domanda: ssm201773) - (riferita allo scenario n.18):

Quale dei seguenti parametri è necessario conoscere per interpretare correttamente questo valore di calcemia?

- ☒ A: Albuminemia
- ☐ B: Proteine totali
- ☐ C: Fosforemia
- ☐ D: PCR
- ☐ E: Gamma globuline

Domanda 39: (codice domanda: ssm201777) :

L'uso di quale dei seguenti farmaci comporta un maggior rischio di ulcera gastrica?

- ☒ A: Ketoprofene
- ☐ B: Paracetamolo
- ☐ C: Tramadolo
- ☐ D: Codeina
- ☐ E: Sucralfato

Domanda 40: (codice domanda: ssm201778) :

Il propranololo è considerato un beta-bloccante non selettivo. Su quali recettori adrenergici agisce?

- ☒ A: Beta 1 e Beta 2
- ☐ B: Solo Beta 2
- ☐ C: Beta 1, Beta 2 e recettori alfa
- ☐ D: Beta 2 e recettori gamma
- ☐ E: Tutti i beta, tutti gli alfa e i gamma

Domanda 41: (codice domanda: ssm201779) :

Il propranololo è indicato nella terapia dell'ipertensione arteriosa. A quale dei seguenti farmaci NON dovrebbe mai essere associato nella terapia dell'ipertensione arteriosa a causa dei possibili effetti collaterali sulla conduzione cardiaca?

- ☒ A: Verapamil
- ☐ B: Ramipril
- ☐ C: Doxazosina
- ☐ D: Valsartan
- ☐ E: Furosemide

Scenario 19:

Una ragazza di 15 anni viene portata dai genitori dalla ginecologa per amenorrea. Presenta anche un limitato sviluppo puberale associato a bassa statura, torace a scudo e bassa attaccatura dei capelli. L'esame ecografico transvaginale mostra la presenza di banderelle fibrose al posto delle ovaie.

Domanda 42: (codice domanda: ssm201783) - (riferita allo scenario n.19):

Qual è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Sindrome di Turner
- ☐ B: Sindrome di Klinefelter
- ☐ C: Sindrome di Down
- ☐ D: Trisomia 18
- ☐ E: Ermafroditismo vero

Domanda 43: (codice domanda: ssm201785) :

Quale dei seguenti esami di laboratorio è più importante e specifico nel monitoraggio di una terapia con metformina, in quanto una sua alterazione significativa è un'indicazione alla sospensione di tale terapia?

- ☒ A: Clearance della creatinina
- ☐ B: Uricemia
- ☐ C: Elettroforesi siero-proteica
- ☐ D: Enzimi di necrosi muscolare (CK)
- ☐ E: Calcemia

Scenario 20:

Un uomo di 80 anni, affetto da diabete mellito tipo II e insufficienza renale cronica, giunge in Pronto Soccorso per febbre, tosse produttiva e dispnea. Un radiogramma del torace evidenzia un addensamento con carattere flogistico in campo inferiore destro. Gli esami ematochimici sono coerenti con un processo infettivo in atto. Si decide di ricoverare il paziente. Il paziente non ha eseguito ricoveri nei precedenti 3 mesi.

Domanda 44: (codice domanda: ssm201786) - (riferita allo scenario n.20):

Nel sospetto di polmonite ad acquisizione comunitaria, quale agente patogeno - tra quelli elencati - abitualmente NON è coinvolto?

- ☒ A: Pseudomonas aeruginosa
- ☐ B: Streptococcus pneumoniae
- ☐ C: Haemophilus influenzae
- ☐ D: Chlamydia pneumoniae
- ☐ E: Mycoplasma pneumoniae

Domanda 45: (codice domanda: ssm201790) :

Nell'ambito dei precursori del carcinoma invasivo dell'esocervice uterina, a cosa corrisponde "moderato grado di displasia"?

- ☒ A: CIN II
- ☐ B: CIN I
- ☐ C: CIN III
- ☐ D: Neoplasia invasiva
- ☐ E: Carcinoma in situ

Scenario 21:

Una giovane coppia si presenta all'osservazione del ginecologo perché non riesce ad avere figli.

Domanda 46: (codice domanda: ssm201791) - (riferita allo scenario n.21):

Quando si può definire una situazione di infertilità?

- ☒ A: Dopo almeno un anno di rapporti frequenti, mirati e non protetti
- ☐ B: Dopo 6 mesi di rapporti non protetti
- ☐ C: Dopo almeno tre anni di rapporti frequenti, mirati e non protetti
- ☐ D: Sull'evidenza di esami strumentali che dimostrano impossibilità a procreare
- ☐ E: Dopo sei mesi di rapporti frequenti, mirati e non protetti

Domanda 47: (codice domanda: ssm201792) - (riferita allo scenario n.21):

Il primo livello diagnostico dovrebbe prevedere:

- ☒ A: indagini diagnostiche per lo studio di una eziologia endocrino-metabolica e anatomica della donna e spermiogramma del partner
- ☐ B: laparoscopia esplorativa e spermiogramma
- ☐ C: dosaggio del TSH, FSH e LH
- ☐ D: dosaggio di FSH, LH e spermiogramma
- ☐ E: colloquio psicologico e studio endocrino metabolico e anatomico della donna

Scenario 22:

A una donna di 32 anni, primipara, con anamnesi precedente alla gravidanza negativa, viene posta diagnosi di ipertensione gestazionale di grado moderato.

Domanda 48: (codice domanda: ssm201793) - (riferita allo scenario n.22):

La paziente viene messa al corrente dei possibili rischi legati a tale patologia, tra cui rientrano tutti i seguenti TRANNE uno. Quale?

- ☒ A: Polidramnios
- ☐ B: Aggravamento con comparsa di proteinuria
- ☐ C: Rischio di patologie cardiovascolari nella quinta decade
- ☐ D: Prematurità e sofferenza fetale cronica
- ☐ E: Distacco intempestivo di placenta

Domanda 49: (codice domanda: ssm201794) - (riferita allo scenario n.22):

La paziente contatta il proprio ginecologo riferendo di avere entrambe le gambe gonfie, senza tuttavia gonfiore in altre sedi. Sulla base di quanto ha raccontato al telefono si consiglia di:

- ☒ A: rivolgersi a un Pronto Soccorso ostetrico per escludere che si tratti di una manifestazione iniziale di preeclampsia
- ☐ B: tranquillizzarsi perché l'edema che accompagna la preeclampsia si rende manifesto sempre anche con gonfiore delle mani e del volto
- ☐ C: recarsi in ospedale per un ricovero perché l'edema degli arti inferiori è sufficiente per porre diagnosi di preeclampsia
- ☐ D: tranquillizzarsi perché gli edemi dipendono solo da problemi di stasi venosa e nulla hanno a che fare con l'ipertensione gestazionale
- ☐ E: tranquillizzarsi perché l'edema che accompagna la preeclampsia si manifesta solo con gonfiore delle mani e del volto

Domanda 50: (codice domanda: ssm201795) - (riferita allo scenario n.22):

La paziente contatta telefonicamente il proprio ginecologo lamentando dolore addominale dopo aver ingerito cibo avariato. Viene quindi invitata a rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso poiché, in considerazione della patologia di base, tale sintomo potrebbe porre in diagnosi differenziale le seguenti patologie:

- ☒ A: HELLP (ipertensione, enzimi epatici elevati e ipopiastrinemia), preeclampsia ed eclampsia
- ☐ B: preeclampsia, diabete gestazionale scompensato
- ☐ C: preeclampsia, eclampsia imminente, non HELLP (ipertensione, enzimi epatici elevati e ipopiastrinemia)
- ☐ D: HELLP (ipertensione, enzimi epatici elevati e ipopiastrinemia) e distacco di placenta fundica
- ☐ E: eclampsia e infezione delle vie urinarie

Scenario 23:

Una paziente di 42 anni, terzigravida-para 0, è molto spaventata perché all'ecografia di screening a 32 settimane è stato riscontrato un eccesso di liquido amniotico.

Domanda 51: (codice domanda: ssm201796) - (riferita allo scenario n.23):

La paziente viene informata che tale condizione non è molto comune e che:

- ☒ A: è necessario eseguire un'ecografia di secondo livello presso un centro di diagnosi prenatale
- ☐ B: l'eccesso di liquido amniotico non può essere sospettato con una semplice ecografia di screening
- ☐ C: è necessario fare una risonanza magnetica per poter confermare l'eccesso di liquido amniotico
- ☐ D: l'eccesso di liquido amniotico si associa sempre e solamente al diabete gestazionale
- ☐ E: l'eccesso di liquido amniotico non è mai una diagnosi solo strumentale

Domanda 52: (codice domanda: ssm2017105) :

Che caratteristiche possiede il vaccino anti morbillo?

- ☒ A: È costituito da microrganismi vivi e attenuati
- ☐ B: È combinato con il vaccino anti pertosse e anti Rotavirus
- ☐ C: Per l'eliminazione è sufficiente ottenere una copertura vaccinale almeno pari all'80%
- ☐ D: È costituito da subunità virali
- ☐ E: È ottenuto mediante la tecnica del DNA ricombinante

Scenario 24:

	Malati	Non malati	TOTALE
Esposti	656	516	1.172
Non esposti	214	386	600
TOTALE	870	902	1.772

In uno studio caso-controllo per comprendere l'eziologia del cancro dell'esofago, 870 casi e 902 controlli sono stati indagati per quanto concerne il consumo abituale di superalcolici.

Domanda 53: (codice domanda: ssm2017106) - (riferita allo scenario n.24):

L'associazione tra la malattia e il fattore di rischio può essere quantificata calcolando:

- ☒ A: OR: $(656 \cdot 386) / (516 \cdot 214)$
- ☐ B: OR: $656/386$
- ☐ C: RR: $(656 / 1172) / (214 / 600)$
- ☐ D: RA: $(656 / 1172) - (214 / 600)$
- ☐ E: RA: $(656 - 214) / 1772$

Domanda 54: (codice domanda: ssm2017107) - (riferita allo scenario n.24):

È generalmente indicato tra i vantaggi degli studi caso-controllo:

- ☒ A: il relativo basso costo e la breve durata
- ☐ B: la possibilità di calcolare la prevalenza puntuale della malattia considerata
- ☐ C: la possibilità di calcolare la prevalenza periodale della malattia considerata
- ☐ D: la possibilità di calcolare l'incidenza della malattia considerata
- ☐ E: la possibilità di calcolare l'incidenza periodale della malattia considerata

Scenario 25:

In una fonderia viene diagnosticato un caso di Legionellosi in un operaio. Si segnala che: le vasche di raffreddamento dei metalli hanno una temperatura controllata pari a 60 °C; gli operai utilizzano la mensa comune per il pasto; utilizzano bagni e docce all'interno dell'azienda; nelle vicinanze della fabbrica non ci sono scavi o lavori edili.

Domanda 55: (codice domanda: ssm2017108) - (riferita allo scenario n.25):

In base ai dati a disposizione, qual è considerata la sorgente più probabile di infezione?

- ☒ A: L'utilizzo dei bagni/docce
- ☐ B: L'inalazione delle acque di raffreddamento dei metalli
- ☐ C: Trasmissione aerea da parte di un altro operaio portatore sano di Legionella pneumophila
- ☐ D: Il consumo di alimenti contaminati in mensa
- ☐ E: Trasmissione da contatto da parte di un altro operaio portatore sano di Legionella pneumophila

Scenario 26:

Un uomo di 63 anni, noto per cirrosi epatica alcolica, si presenta in Pronto Soccorso per distensione addominale e febbre. La temperatura corporea è 38.2 °C. L'addome è trattabile ma diffusamente dolorabile alla palpazione superficiale.

Domanda 56: (codice domanda: ssm2017113) - (riferita allo scenario n.26):

Viene posto il sospetto di peritonite batterica spontanea. Quale dei seguenti batteri è più frequentemente responsabile di tale complicanza?

- ☒ A: Escherichia coli
- ☐ B: Pseudomonas aeruginosa
- ☐ C: Staphylococcus aureus
- ☐ D: Enterococcus faecalis
- ☐ E: Klebsiella pneumoniae

Scenario 27:

Un uomo di 57 anni si presenta in Pronto Soccorso lamentando dolore epigastrico, irradiato a cintura alla schiena, insorto improvvisamente, intenso e continuo. All'esame obiettivo egli si presenta sofferente; non si rilevano segni di peritonite né di perforazione intestinale. Agli esami ematochimici si osserva incremento dell'amilasemia (1.400 UI/L, valori normali: 20-100 UI/L).

Domanda 57: (codice domanda: ssm2017114) - (riferita allo scenario n.27):

Nel contesto di un approccio diagnostico, quale delle seguenti affermazioni è corretta in riferimento al quadro clinico?

- ☒ A: Sulla base dei dati disponibili è possibile formulare diagnosi di pancreatite acuta
- ☐ B: Non si può porre diagnosi di pancreatite acuta se non dopo aver eseguito anche una TC addome con mezzo di contrasto
- ☐ C: Non si può porre diagnosi di pancreatite acuta se non dopo aver eseguito anche una ecografia dell'addome
- ☐ D: Per poter porre diagnosi di pancreatite acuta è necessario eseguire una ecoendoscopia
- ☐ E: Non è possibile formulare diagnosi di pancreatite acuta se non eseguendo anche una RM addome con gadolinio

Scenario 28:

Un uomo di 63 anni affetto da cirrosi epatica alcolica con ascite, viene sottoposto a valutazione della prognosi della malattia con punteggio di Child-Pugh.

Domanda 58: (codice domanda: ssm2017115) - (riferita allo scenario n.28):

Oltre alla presenza e al grado di ascite, tutti i seguenti sono parametri da considerare nel calcolo dello score di Child-Pugh, TRANNE uno; quale?

- ☒ A: Presenza e grado di varici esofagee
- ☐ B: Presenza e grado di encefalopatia
- ☐ C: Valore di bilirubina
- ☐ D: Valore di albumina
- ☐ E: Valore dell'INR

Scenario 29:

Un ragazzo di 26 anni giunge in Pronto Soccorso lamentando dispnea insorta a breve distanza da un improvviso dolore all'emitorace di sinistra. EO: PA 110/60 mmHg, FC 96/min ritmico, SpO₂ 88% in aria ambiente; MV assente in campo superiore sinistro; temperatura corporea 36.7 °C.

Domanda 59: (codice domanda: ssm2017119) - (riferita allo scenario n.29):

Quale dei seguenti è l'evento che più probabilmente si è verificato in questo paziente?

- ☒ A: Pneumotorace spontaneo
- ☐ B: Infarto polmonare
- ☐ C: Infarto miocardico
- ☐ D: Emotorace
- ☐ E: Chilotorace

Domanda 60: (codice domanda: ssm2017120) - (riferita allo scenario n.29):

Quale esame diagnostico è opportuno scegliere come primo approccio?

- ☒ A: RX torace
- ☐ B: Spirometria
- ☐ C: Dosaggio troponina
- ☐ D: TC del torace con mezzo di contrasto
- ☐ E: Ecocardiogramma transtoracico

Domanda 61: (codice domanda: ssm2017121) - (riferita allo scenario n.29):

Quale dei seguenti è un noto fattore di rischio per lo sviluppo dell'evento che più probabilmente si è verificato in questo paziente?

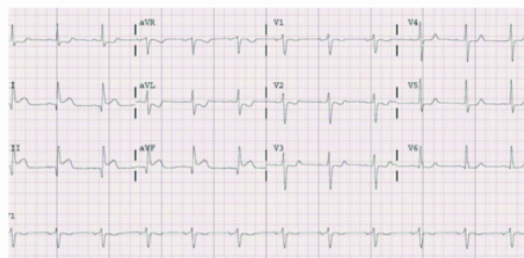
- ☒ A: Fumo di sigaretta
- ☐ B: Consumo di alcool
- ☐ C: Sedentarietà
- ☐ D: Obesità
- ☐ E: Consumo di eroina endovena

Domanda 62: (codice domanda: ssm2017125) :

Qual è la più comune causa di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV)?

- ☒ A: Tachicardia da rientro nodale
- ☐ B: Tachicardia da rientro atrio-ventricolare
- ☐ C: Sindrome di Wolff-Parkinson-White
- ☐ D: Flutter atriale tipico
- ☐ E: Flutter atriale atipico

Scenario 30:



Uomo, 48 anni, fumatore, iperteso in terapia con ACE inibitore. Lamenta dolore epigastrico da circa 6h. Vengono rilevati i seguenti parametri PA 90/50 mmHg, FC 57/min, satO2 99% e viene eseguito un ECG come mostrato in figura.

Domanda 63: (codice domanda: ssm2017126) - (riferita allo scenario n.30):

Le alterazioni presenti sono compatibili con:

- ☒ A: STEMI inferiore
- ☐ B: STEMI anteriore
- ☐ C: Pericardite
- ☐ D: Probabile infarto anteriore pregresso
- ☐ E: STEMI antero-laterale

Domanda 64: (codice domanda: ssm2017127) - (riferita allo scenario n.30):

Mentre si allerta la sala di emodinamica è opportuno iniziare la somministrazione di:

- ☒ A: ticagrelor
- ☐ B: warfarin
- ☐ C: diltiazem
- ☐ D: enalapril
- ☐ E: nitroprussiato di sodio

Domanda 65: (codice domanda: ssm2017128) - (riferita allo scenario n.30):

Verosimilmente il paziente avrà una lesione a carico di:

- ☒ A: coronaria destra
- ☐ B: coronaria sinistra
- ☐ C: tronco comune
- ☐ D: discendente anteriore
- ☐ E: ramo del margine ottuso

Scenario 31:

All'auscultazione cardiaca, una paziente di 37 anni presenta un soffio meso-telesistolico 3/6 meglio udibile in mesocardio e in corrispondenza dell'apice cardiaco. Il resto dell'esame obiettivo, i parametri vitali e gli esami ematochimici sono nei limiti.

Domanda 66: (codice domanda: ssm2017129) - (riferita allo scenario n.31):

Tale reperto è maggiormente indicativo di quale dei seguenti difetti anatomici?

- ☒ A: Insufficienza mitralica
- ☐ B: Insufficienza aortica
- ☐ C: Difetto interventricolare
- ☐ D: Dotto di Botallo pervio
- ☐ E: Stenosi mitralica

Domanda 67: (codice domanda: ssm2017130) - (riferita allo scenario n.31):

La paziente riferisce anche palpitazioni aritmiche. Qual è, con maggiore probabilità, la patologia aritmica responsabile di tali palpitazioni?

- ☒ A: Fibrillazione atriale
- ☐ B: Tachicardia da rientro atrio-ventricolare
- ☐ C: Tachicardia da rientro nodale
- ☐ D: Extrasistolia ventricolare complessa
- ☐ E: Fibrillazione ventricolare

Scenario 32:

Una donna di 67 anni viene portata in Pronto Soccorso con un quadro di febbre (TC 38.8 °C), alterato stato di coscienza, ipotensione (PA 80/40 mmHg), tachicardia (FC 100 bpm), tachipnea (FR 25 atti/min), saturazione dell'ossigeno 82% in aria ambiente. Agli esami ematobiochimici si riscontrano leucocitosi neutrofila (GB 22000/mm³; neutrofili 84%); creatininemia e parametri di funzione epatica nei limiti, iperlattacidemia. Viene sospettato uno shock settico.

Domanda 68: (codice domanda: ssm2017137) - (riferita allo scenario n.32):

Quali tra i seguenti parametri per lo screening rapido dello shock settico costituiscono il quick SOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment) score?

- ☒ A: Frequenza respiratoria, stato di coscienza, pressione arteriosa
- ☐ B: Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione dell'ossigeno
- ☐ C: Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, globuli bianchi, temperatura corporea
- ☐ D: Pressione arteriosa, stato di coscienza, temperatura corporea
- ☐ E: Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, stato di coscienza, lattati ematici

Domanda 69: (codice domanda: ssm2017138) - (riferita allo scenario n.32):

In caso di sepsi e shock settico, dal punto di vista della terapia antibiotica iniziale, qual è l'approccio più corretto da assumere?

- ☒ A: La terapia antibiotica empirica parenterale va iniziata il prima possibile, preferibilmente entro la prima ora dalla diagnosi di shock settico, previo prelievo di campione per emocolture (almeno due set), con antibiotici ad ampio spettro
- ☐ B: La terapia antibiotica va iniziata immediatamente, le emocolture possono non essere eseguite in quanto non è fondamentale conoscere l'eziologia della sepsi; la terapia deve essere quindi ad ampio spettro con l'associazione di almeno due farmaci
- ☐ C: La terapia antibiotica va iniziata entro due ore dalla diagnosi, indifferentemente prima o dopo aver eseguito le emocolture, e deve essere ad ampio spettro
- ☐ D: La terapia antibiotica va iniziata entro due ore dalla diagnosi, dopo aver prelevato il campione per le emocolture, deve essere ad ampio spettro ed essere sempre associata a terapia antifungina empirica
- ☐ E: La terapia antibiotica va iniziata entro due ore dalla diagnosi, dopo aver prelevato il campione per le emocolture, deve essere mirata alla possibile causa dell'infezione, e non ad ampio spettro, al fine di evitare lo sviluppo di antibiotico-resistenze

Scenario 33:

Un uomo di 30 anni giunge in Pronto Soccorso con febbre (TC 39,5 °C), confusione mentale, mialgie. Agli esami di laboratorio si rilevano leucopenia e piastrinopenia oltre che anemia. Da un paio di settimane è tornato dal Ruanda. Non ha effettuato profilassi antimalarica. All'esame dello striscio di sangue e in goccia spessa si pone la diagnosi di malaria da *Plasmodium falciparum*.

Domanda 70: (codice domanda: ssm2017139) - (riferita allo scenario n.33):

Qual è la specie di zanzara più verosimilmente implicata nella trasmissione della malaria?

- ☒ A: *Anopheles gambiae*
- ☐ B: *Anopheles labranchiae*
- ☐ C: *Anopheles superpictus*
- ☐ D: *Anopheles maculipennis*
- ☐ E: *Anopheles atroparvus*

Scenario 34:

Un paziente noto per TVP recidivanti lamenta improvvisa difficoltà respiratoria.

Domanda 71: (codice domanda: ssm2017142) - (riferita allo scenario n.34):

In considerazione dell'anamnesi remota e della sintomatologia suggestiva per embolia polmonare, quale delle seguenti condizioni aumenta maggiormente la probabilità di tale diagnosi?

- ☒ A: TVP in atto
- ☐ B: FC 100/min
- ☐ C: Presenza di emottisi
- ☐ D: Allettamento per almeno 3 giorni
- ☐ E: Fibrillazione atriale

Domanda 72: (codice domanda: ssm2017143) - (riferita allo scenario n.34):

Qual è il quadro ecocardiografico maggiormente indicativo di embolia polmonare severa?

- ☒ A: Ventricolo destro dilatato ipocinetico
- ☐ B: Insufficienza mitralica
- ☐ C: Dilatazione del ventricolo sinistro
- ☐ D: Ventricolo destro ipercinetico
- ☐ E: Trombo nel ventricolo destro

Domanda 73: (codice domanda: ssm2017144) - (riferita allo scenario n.34):

Quale indagine è dirimente per la diagnosi di embolia polmonare?

- ☒ A: Angio-TC toracica
- ☐ B: RM toracica
- ☐ C: Ecocardiografia
- ☐ D: Dosaggio D-dimero
- ☐ E: RX torace

Scenario 35:

Un operaio edile utilizza quotidianamente e per diverse ore trapano e martello pneumatico.

Domanda 74: (codice domanda: ssm2017148) - (riferita allo scenario n.35):

Il paziente potrebbe manifestare e ottenere automaticamente il riconoscimento di tutte le seguenti malattie professionali, TRANNE una; quale?

- ☒ A: Malattia di Dupuytren (ispessimento e retrazione sclerotica dell'aponeurosi palmare)
- ☐ B: Osteoartropatie del polso
- ☐ C: Neuropatie periferiche del nervo mediano
- ☐ D: Osteoartropatie del gomito e della spalla
- ☐ E: Neuropatie periferiche del nervo ulnare

Domanda 75: (codice domanda: ssm2017149) - (riferita allo scenario n.35):

L'uomo inoltre manifesta una lesione radiologica caratteristica della patologia da vibrazioni e nota come "Malattia di Kienbock", ovvero:

- ☒ A: la necrosi del semilunare
- ☐ B: la necrosi della testa omerale
- ☐ C: deviazione cubitale delle articolazioni metacarpo-falangee
- ☐ D: pseudoartrosi dello stiloide radiale
- ☐ E: pseudoartrosi dello stiloide ulnare

Scenario 36:

Un fruttivendolo di 45 anni ha avvertito un dolore acutissimo in regione lombare e alla superficie posteriore della coscia e del polpaccio sinistro mentre sollevava un cassetta pesante piena di frutta.

Domanda 76: (codice domanda: ssm2017152) - (riferita allo scenario n.36):

Dopo aver raccolto l'anamnesi, il medico visita il paziente ed effettua il segno di Lasègue, che risulta positivo. In che cosa consiste questo test?

- ☒ A: Nell'evocazione di dolore lungo il decorso del nervo sciatico alla flessione passiva dell'anca, mantenendo estesa l'articolazione del ginocchio
- ☐ B: Nel dolore che si evoca alla pressione esercitata sulla testa del perone
- ☐ C: Nell'ipoalidità alla flessione dorsale dell'alluce contro resistenza
- ☐ D: Nel dolore evocato alla pressione sulla linea paravertebrale
- ☐ E: Nella difficoltà a mantenersi "in punta di piedi"

Scenario 37:

Si presenta alla visita un uomo di 30 anni con gonalgia diffusa, comparsa da alcuni giorni dopo trauma distorsivo del ginocchio mentre giocava a calcetto. Coesistono sensazione di instabilità e cedimento articolare.

Domanda 77: (codice domanda: ssm2017153) - (riferita allo scenario n.37):

Sospettando una lesione legamentosa, quale reperto clinico ci si aspetta di riscontrare?

- ☒ A: Cassetto anteriore
- ☐ B: Blocco completo dell'articolazione
- ☐ C: Perdita del riflesso rotuleo
- ☐ D: Dolore nel movimento di lateralizzazione della rotula
- ☐ E: Presenza costante di cisti poplitea di Baker

Domanda 78: (codice domanda: ssm2017156) :

Quale delle seguenti malattie si associa al deficit di alfa1 antitripsina?

- ☒ A: Cirrosi epatica
- ☐ B: Cardiomiopatia ipertrofica
- ☐ C: Cataratta
- ☐ D: Vasculopatia cerebrale
- ☐ E: Sordità neuro-sensoriale

Domanda 79: (codice domanda: ssm2017157) :

Quale delle seguenti condizioni NON si riscontra comunemente nella sclerosi sistemica?

- ☒ A: Cataratta
- ☐ B: Sclerodattilia
- ☐ C: Fenomeno di Raynaud
- ☐ D: Teleangectasie
- ☐ E: Ipomotilità esofagea

Domanda 80: (codice domanda: ssm2017158) :

Quale dei seguenti reperti NON è tipicamente presente in caso di insufficienza renale cronica?

- ☒ A: Ipotrigliceridemia
- ☐ B: Incremento del paratormone
- ☐ C: Anemia
- ☐ D: Edemi
- ☐ E: Ipocalcemia

Scenario 38:

Un uomo di 53 anni si sottopone a una TC del torace con mezzo di contrasto in seguito all'insorgenza di dispnea progressiva, accompagnata da tosse e raucedine. Si evidenzia la presenza di un aneurisma dell'aorta discendente del diametro di circa 7,5 cm.

Domanda 81: (codice domanda: ssm2017159) - (riferita allo scenario n.38):

Quale delle seguenti malattie sistemiche NON è associata a un rischio incrementato di sviluppare aneurismi dell'aorta toracica?

- ☒ A: Fibrosi cistica
- ☐ B: Sindrome di Ehlers-Danlos tipo IV
- ☐ C: Arterite gigantocellulare
- ☐ D: Sifilide
- ☐ E: Sindrome di Marfan

Scenario 39:

Una donna di 28 anni in buone condizioni di salute vuole iniziare una terapia anticoncezionale con un estroprogestinico. Su consiglio del medico curante si sottopone a una dettagliata valutazione dei fattori di rischio pro-trombotici, in virtù del fatto che la madre, qualche anno prima, aveva avuto una tromboembolia polmonare. Gli esami risultano nei limiti di norma, fatta eccezione per la presenza di resistenza alla proteina C attivata.

Domanda 82: (codice domanda: ssm2017160) - (riferita allo scenario n.39):

In quale delle seguenti proteine della coagulazione si verifica una mutazione tipicamente associata a tale dato di laboratorio?

- ☒ A: Fattore V
- ☐ B: Fibrinogeno
- ☐ C: Proteina S
- ☐ D: Antitrombina
- ☐ E: Fattore II

Scenario 40:

Una donna di 32 anni si presenta con tosse e dispnea da due settimane. L'RX del torace rivela linfadenopatie ilari e plurimi noduli bilaterali confluenti. Esegue approfondimenti di imaging, broncolavaggio e biopsia.

Domanda 83: (codice domanda: ssm2017161) - (riferita allo scenario n.40):

All'esame citologico si dimostrano CD4/CD8>2 e all'esame istologico la presenza di granulomi epitelioidi senza necrosi caseosa. Si decide di dosare l'ACE nel siero, che risulta elevato. Qual è l'ipotesi diagnostica?

- ☒ A: Sarcoidosi
- ☐ B: Polmonite
- ☐ C: Tubercolosi
- ☐ D: Pneumoconiosi
- ☐ E: Adenocarcinoma polmonare

Domanda 84: (codice domanda: ssm2017162) :

Quale tra i seguenti farmaci NON ha indicazione per il trattamento dell'osteoporosi?

- ☒ A: Corticosteroidi
- ☐ B: Ibandronato
- ☐ C: Teriparatide
- ☐ D: Denosumab
- ☐ E: Alendronato

Scenario 41:

A un paziente di 47 anni viene riscontrata una retinopatia ipertensiva durante esecuzione di un fundus oculi. La misurazione della pressione arteriosa risulta 160/105 mmHg. Tale valore viene confermato da altre due misurazioni durante la settimana.

Domanda 85: (codice domanda: ssm2017163) - (riferita allo scenario n.41):

Nel sospetto di una ipertensione arteriosa secondaria di natura nefro-vascolare, quale sintomo/segno è opportuno ricercare?

- ☒ A: Soffio addominale periombelicale
- ☐ B: Calo ponderale
- ☐ C: Poliuria
- ☐ D: Sudorazione
- ☐ E: Ematuria

Domanda 86: (codice domanda: ssm2017164) - (riferita allo scenario n.41):

Nel caso l'ipertensione fosse secondaria a una stenosi dell'arteria renale, quale tra le seguenti opzioni terapeutiche risulterebbe la più appropriata?

- ☒ A: Correzione endovascolare della stenosi
- ☐ B: Ace inibitori in monoterapia
- ☐ C: Ace inibitori associati a diuretici
- ☐ D: Sartani associati a beta-bloccanti
- ☐ E: Dieta iposodica

Scenario 42:

Un paziente si presenta in Pronto Soccorso con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Vengono eseguiti un prelievo e RX torace che documenta una polmonite lobare sinistra.

Domanda 87: (codice domanda: ssm2017165) - (riferita allo scenario n.42):

In un uomo adulto senza comorbidità quale trattamento antibiotico NON è appropriato in una terapia empirica?

- ☒ A: Metronidazolo
- ☐ B: Levofloxacina
- ☐ C: Ceftriaxone
- ☐ D: Amoxicillina
- ☐ E: Ampicillina

Scenario 43:

Una signora di 67 anni viene trovata morta dal figlio nel proprio appartamento a Roma. Quando arrivano i Carabinieri la trovano sdraiata supina sul letto con le braccia flesse sotto al capo. Le finestre della casa sono chiuse e la temperatura ambientale è di 20 °C. Il medico legale, durante il sopralluogo, esegue la misurazione della temperatura corporea del cadavere per via rettale che risulta pari a 36 °C all'inizio del sopralluogo e di 35,5 °C alla rilevazione finale (circa un'ora dopo). Non è presente rigidità cadaverica, ma sono presenti sfumate macchie ipostatiche ai glutei e alle spalle. Esternamente sono presenti delle lesioni "sospette" sul collo e sul torace della paziente che rendono necessaria l'esecuzione dell'esame autoptico.

Domanda 88: (codice domanda: ssm2017176) - (riferita allo scenario n.43):

I dati identificati dal medico legale hanno permesso di determinare l'epoca della morte della signora, stimando che il decesso sia avvenuto verosimilmente:

- ☒ A: entro le tre ore antecedenti il sopralluogo
- ☐ B: tra le 12 e le 24 ore antecedenti il sopralluogo
- ☐ C: tra le 24 e le 48 ore antecedenti il sopralluogo
- ☐ D: circa tre giorni prima del sopralluogo
- ☐ E: una settimana prima del sopralluogo

Domanda 89: (codice domanda: ssm2017177) - (riferita allo scenario n.43):

Il cadavere viene pertanto trasferito presso l'Istituto di Medicina Legale per essere sottoposto ad autopsia giudiziaria. L'obiettività esterna rilevata mostra: la presenza di lesioni ecchimotiche di tipo figurato, localizzate alle superfici antero-laterali del collo; alcune lesioni a forma di semiluna, attribuibili a unghiate. L'esame interno rivela: infiltrazioni emorragiche dei fasci muscolari e vascolo-nervosi del collo; lesioni dell'osso ioide e rottura delle cartilagini tiroidea e cricoidea della laringe.

Alla luce di tali reperti, a quale diagnosi è attribuibile il decesso della donna?

- ☒ A: Asfissia da strozzamento-strangolamento manuale
- ☐ B: Asfissia da confinamento
- ☐ C: Impiccamento
- ☐ D: Annegamento
- ☐ E: Asfissia da soffocamento

Domanda 90: (codice domanda: ssm2017180) :

Quale colorazione viene utilizzata in microbiologia per visualizzare i micobatteri nell'espettorato?

- ☒ A: Ziehl-Neelsen
- ☐ B: Ziehl-Neelsen modificata
- ☐ C: Colorazione tricromica
- ☐ D: Ematossilina-eosina
- ☐ E: Colorazione di Gram

Scenario 44:

A un caso di sospetta meningite, viene effettuata puntura lombare; all'esame microscopico del liquido cefalorachidiano, dopo colorazione di Gram, si osservano diplococchi Gram negativi a chicco di caffè.

Domanda 91: (codice domanda: ssm2017181) - (riferita allo scenario n.44):

Qual è l'agente microbico identificato in base all'esame Gram?

- ☒ A: Neisseria meningitidis
- ☐ B: Streptococcus pneumoniae
- ☐ C: Staphylococcus Aureus
- ☐ D: Escherichia coli
- ☐ E: Listeria monocytogenes

Scenario 45:

Una donna di 63 anni a un controllo di esami di routine presenta: creatinina sierica 1.4 mg/dL, calcemia 11.2 mg/dL, fosforemia 2.4 mg/dL, PTH intatto 220 pg/mL, fosfatasi alcalina 280 UI/L; esame urine: PS 1.016, pH 7.0, proteinuria ass, GR 4-5/campo, leucociti 25/campo. Tredici anni fa è stata sottoposta a quadrantectomia per carcinoma mammario, con successivo follow-up negativo; da circa 8 anni riferisce valori moderatamente elevati di pressione arteriosa, per cui assume in modo irregolare un diuretico tiazidico; da circa 5 anni soffre di nefrolitiasi, inizialmente espulsiva, ultimamente complicatasi con nefrolitiasi a stampo infetta. L'esame obiettivo generale è sostanzialmente nei limiti di norma, con un modico grado di ipertensione sistolica (148/82).

Domanda 92: (codice domanda: ssm2017184) - (riferita allo scenario n.45):

Qual è la diagnosi più probabile in questa paziente?

- ☒ A: Iperparatiroidismo primitivo
- ☐ B: Iperparatiroidismo secondario a insufficienza renale cronica
- ☐ C: Ipercalcemia da diuretico tiazidico
- ☐ D: Ipercalcemia secondaria a metastasi ossee da ripresa del carcinoma mammario
- ☐ E: Sarcoidosi

Domanda 93: (codice domanda: ssm2017185) - (riferita allo scenario n.45):

Formulata la diagnosi, quale delle seguenti indicazioni terapeutiche è la più appropriata?

- ☒ A: Esecuzione di paratiroidectomia/adenomectomia
- ☐ B: Supplementazione con vitamina D, per tentare di sopprimere il PTH
- ☐ C: Supplementazione con fosfato, per correggere l'ipofosforemia
- ☐ D: Avvio di terapia steroidea sistemica
- ☐ E: Somministrazione di pamidronato 90 mg

Scenario 46:

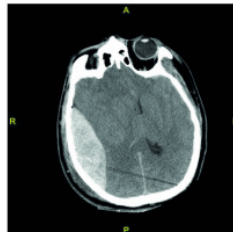
Un ragazzo di 23 anni è vittima di un incidente automobilistico (moto contro auto). All'arrivo dei soccorsi viene riferito il seguente esame obiettivo neurologico: il paziente giace a occhi chiusi, non li apre né allo stimolo verbale né allo stimolo doloroso, eloquio assente, alla stimolazione algica il paziente tende ad allontanare gli arti dalla fonte dello stimolo. Presenta anisocoria per destra > sinistra.

Domanda 94: (codice domanda: ssm2017188) - (riferita allo scenario n.46):

Qual è il valore della Glasgow Coma Scale di questo paziente?

- ☒ A: 6
- ☐ B: 3
- ☐ C: 9
- ☐ D: 12
- ☐ E: 15

Domanda 95: (codice domanda: ssm2017189) - (riferita allo scenario n.46):



Il paziente viene trasferito presso il Pronto Soccorso dove viene sottoposto a una TC cerebrale (riportata in figura). Quale reperto è verosimilmente apprezzabile alla TC?

- ☒ A: Ematoma epidurale
- ☐ B: Ematoma sottodurale acuto
- ☐ C: Ematoma sottodurale cronico
- ☐ D: Ematoma intraparenchimale
- ☐ E: Ematoma subgaleale

Scenario 47:

Un paziente destrimane presenta un'afasia espressiva caratterizzata da linguaggio spontaneo non fluente, difficoltà articolatorie e aprassia bucco-facciale.

Domanda 96: (codice domanda: ssm2017192) - (riferita allo scenario n.47):

La lesione causa della sintomatologia si trova più probabilmente in sede:

- ☒ A: frontale sinistra
- ☐ B: temporale destra
- ☐ C: frontale destra
- ☐ D: temporale sinistra
- ☐ E: occipitale sinistra

Scenario 48:

Un paziente di 67 anni giunge all'attenzione del neurologo per decadimento cognitivo rapidamente progressivo associato a insonnia e irritabilità. Viene posto il sospetto di malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD).

Domanda 97: (codice domanda: ssm2017193) - (riferita allo scenario n.48):

Oltre alla rachicentesi, quale pattern di accertamento diagnostico è indicato?

- ☒ A: RM encefalo ed EEG
- ☐ B: PET encefalo ed EEG
- ☐ C: TC encefalo ed EEG
- ☐ D: RM encefalo e valutazione neuropsicologica
- ☐ E: Potenziali evocati ed EEG

Domanda 98: (codice domanda: ssm2017194) - (riferita allo scenario n.48):

La diagnosi è confermata quando nell'esame liquorale si osserva:

- ☒ A: la presenza della proteina 14-3-3 liquorale
- ☐ B: l'assenza della proteina 14-3-3 liquorale
- ☐ C: l'incremento della proteina tau liquorale
- ☐ D: la diminuzione della proteina tau liquorale
- ☐ E: l'assenza della proteina 14-3-3 liquorale e la diminuzione della proteina tau liquorale

Scenario 49:

"Un ragazzo di 15 anni giunge in Pronto Soccorso accompagnato da un compagno di classe. Quest'ultimo è fortemente preoccupato perché l'amico ha espresso il desiderio di morire buttandosi nel Tevere. Da alcuni mesi è divenuto cupo e solitario, ha smesso di frequentare gli amici e sembra pensare sempre alle stesse cose: colpe passate, morte e vissuti di indegnità. Nelle ultime settimane ha dapprima sviluppato idee di morte e quindi un preciso piano suicidario. Il neuropsichiatra, dopo una accurata valutazione, ritiene necessario il ricovero per un verosimile disturbo depressivo maggiore con elevato rischio suicidario. Il paziente tuttavia rifiuta il ricovero affermando che non ha bisogno di cure e che si recherà in riva al Tevere per riflettere un po'."

Domanda 99: (codice domanda: ssm2017198) - (riferita allo scenario n.49):

Sulla base dei dati clinici in possesso, il neuropsichiatra infantile dovrebbe:

- ☒ A: contattare i genitori, e, se questi sono contrari al ricovero, contattare il giudice tutelare per essere autorizzato al ricovero
- ☐ B: affidare il ragazzo ai genitori se contattabili telefonicamente, altrimenti all'amico
- ☐ C: chiedere al Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile il permesso di effettuare un TSO
- ☐ D: contattare il tribunale dei minori per essere autorizzato a effettuare un TSO senza coinvolgere i genitori
- ☐ E: assecondare il volere del paziente e lasciarlo andare, affidandolo al compagno di classe

Scenario 50:

Un uomo di 46 anni, in buona salute generale, da 2 giorni riferisce insistenti miodesopsie nell'occhio destro e alcuni fosfeni. Nelle ultime ore racconta di avere la sensazione che il campo visivo di quell'occhio si sia ristretto, come se ci fosse un'ombra nera periferica.

Domanda 100: (codice domanda: ssm2017200) - (riferita allo scenario n.50):

Quale tra le seguenti diagnosi è la più probabile in base ai sintomi che riferisce?

- ☒ A: Distacco di retina
- ☐ B: Neuropatia ottica retrobulbare
- ☐ C: Neuropatia ottica ischemia anteriore
- ☐ D: Degenerazione a bava di lumaca
- ☐ E: Glaucoma acuto

Scenario 51:

Una paziente di 72 anni, operata di cataratta 2 giorni prima. È molto preoccupata perché riferisce di avere notevole dolore, l'occhio molto rosso e di non vedere quasi più nulla nell'occhio operato.

Domanda 101: (codice domanda: ssm2017201) - (riferita allo scenario n.51):

Quale tra queste diagnosi va prontamente identificata, anche in considerazione della sua gravità?

- ☒ A: Endoftalmite acuta
- ☐ B: Lussazione del cristallino
- ☐ C: Congiuntivite acuta
- ☐ D: Distacco di retina
- ☐ E: Neurite ottica

Scenario 52:

Un giovane paziente di 36 anni, affetto dall'età di 6 anni da diabete mellito di tipo 1, porta in visione la fluorangiografia che ha appena eseguito. Il referto parla di aree ischemiche periferiche e di neovasi epipapillari.

Domanda 102: (codice domanda: ssm2017202) - (riferita allo scenario n.52):

Quale tra i seguenti quadri clinici rispecchia la situazione descritta?

- ☒ A: Retinopatia diabetica proliferante
- ☐ B: Retinopatia diabetica non proliferante severa
- ☐ C: Emovitreo
- ☐ D: Edema maculare
- ☐ E: Trombosi venosa retinica

Domanda 103: (codice domanda: ssm2017206) :

Qual è l'organo più frequentemente interessato dalle metastasi di carcinoma gastrico per via ematogena?

- ☒ A: Fegato
- ☐ B: Encefalo
- ☐ C: Ossa
- ☐ D: Ovaio
- ☐ E: Polmone

Scenario 53:

A una donna viene diagnosticato un carcinoma renale a cellule chiare con metastasi polmonari. La paziente inizia il trattamento biologico di prima linea con un inibitore delle chinasi (multi-targeted receptor tyrosine kinase, RTK).

Domanda 104: (codice domanda: ssm2017207) - (riferita allo scenario n.53):

Tra i farmaci biologici elencati, qual è l'agente terapeutico che la paziente sta assumendo per la patologia in anamnesi?

- ☒ A: Sunitinib
- ☐ B: Trastuzumab
- ☐ C: Bevacizumab
- ☐ D: Cetuximab
- ☐ E: Ipilimumab

Scenario 54:

Un uomo di 69 anni, portatore di microcitoma polmonare con secondarismi epatici, lamenta da circa 7 giorni cefalea, episodi di vertigini e diplopia.

Domanda 105: (codice domanda: ssm2017208) - (riferita allo scenario n.54):

Considerati l'anamnesi e i sintomi presentati, quale potrebbe essere l'esame diagnostico di scelta in questa condizione?

- ☒ A: TC con mezzo di contrasto
- ☐ B: RX delle ossa del cranio
- ☐ C: PET con FDG (fluorodesossiglucosio)
- ☐ D: PET con colina
- ☐ E: Scan osseo con 99mTc-MDP

Scenario 55:

Una signora di 66 anni viene sottoposta a colonscopia per la positività del sangue occulto fecale in tre campioni, eseguiti nell'ambito dello screening per la prevenzione del carcinoma del colon-retto. A livello del colon discendente viene individuato un polipo di due centimetri.

Domanda 106: (codice domanda: ssm2017209) - (riferita allo scenario n.55):

Quale tra i seguenti tipi istologici di polipo si associa più frequentemente alla trasformazione neoplastica?

- ☒ A: Polipo adenomatoso villosa
- ☐ B: Polipo adenomatoso tubulare
- ☐ C: Polipo iperplastico (mucosa iperplastica proliferante)
- ☐ D: Amartoma (polipo giovanile)
- ☐ E: Polipo infiammatorio

Domanda 107: (codice domanda: ssm2017213) :

In cosa consiste l'intervento di stabilizzazione di spalla secondo Latarjet?

- ☒ A: Intervento di trasposizione dell'apofisi coracoide sul bordo anteriore della cavità glenoidea
- ☐ B: Intervento di artrodesi dell'articolazione gleno-omeroale
- ☐ C: Intervento di artrodesi dell'articolazione acromion-claveare
- ☐ D: Sutura della cuffia dei rotatori in artroscopia
- ☐ E: Sutura del cercine glenoideo in artroscopia

Scenario 56:

Un calciatore professionista di 26 anni durante una partita subisce un trauma indiretto al ginocchio sinistro. Durante un gesto tecnico il piede rimane bloccato al suolo con conseguente atteggiamento in valgo ed extrarotazione del ginocchio. All'esame obiettivo viene evidenziata notevole tumefazione del ginocchio e limitazione funzionale.

Domanda 108: (codice domanda: ssm2017214) - (riferita allo scenario n.56):

Quale tra questi legamenti è con più probabilità coinvolto in questa dinamica traumatica?

- ☒ A: Legamento crociato anteriore
- ☐ B: Legamento crociato posteriore
- ☐ C: Legamento posteriore obliquo
- ☐ D: Legamento collaterale laterale
- ☐ E: Legamento arcuato

Domanda 109: (codice domanda: ssm2017215) - (riferita allo scenario n.56):

Quale tra i seguenti test clinici è il più idoneo nella valutazione della lesione del legamento coinvolto?

- ☒ A: Lachman test
- ☐ B: Test del cassetto posteriore
- ☐ C: Test di Godfrey
- ☐ D: Test di Muller
- ☐ E: Test di Apley

Domanda 110: (codice domanda: ssm2017216) - (riferita allo scenario n.56):

In seguito a un trauma distorsivo del ginocchio di alto grado spesso si ha il coinvolgimento di più strutture articolari. Questa tipologia di lesione prende il nome di triade di O'Donoghue. Quali strutture risultano coinvolte?

- ☒ A: Legamento crociato anteriore, legamento collaterale mediale e menisco mediale
- ☐ B: Legamento crociato anteriore, legamento crociato posteriore e legamento collaterale laterale
- ☐ C: Legamento crociato anteriore, legamento collaterale laterale e menisco laterale
- ☐ D: Legamento collaterale mediale, legamento collaterale laterale e menisco mediale
- ☐ E: Legamento collaterale mediale, legamento crociato posteriore e menisco laterale

Scenario 57:



Un uomo di 37 anni si presenta al Pronto Soccorso per intensa sintomatologia algica al livello della spalla destra. Il paziente riferisce caduta accidentale sul palmo della mano con la spalla atteggiata in modica abduzione ed estensione.

Domanda 111: (codice domanda: ssm2017217) - (riferita allo scenario n.57):

Dopo la valutazione dell'esame radiografico, quale diagnosi si sospetta?

- ☒ A: Lussazione anteriore dell'articolazione gleno-omeroale
- ☐ B: Frattura del trochite
- ☐ C: Frattura della cavità glenoide
- ☐ D: Lussazione dell'articolazione acromion-claveare
- ☐ E: Lussazione posteriore dell'articolazione gleno-omeroale

Scenario 58:

Ragazzo di 17 anni, giunge per ostruzione respiratoria nasale bilaterale insorta nella stagione primaverile, rinorrea sierosa, iperemia congiuntivale e iposmia. Riferisce analoga sintomatologia un anno prima, risoltasi poi spontaneamente durante il periodo estivo.

Domanda 112: (codice domanda: ssm2017223) - (riferita allo scenario n.58):

Quale diagnosi è più probabile?

- ☒ A: Rinite allergica
- ☐ B: Rinite vasomotoria
- ☐ C: Poliposi naso-sinusale
- ☐ D: Rinosinusite acuta purulenta
- ☐ E: Coriza

Domanda 113: (codice domanda: ssm2017224) - (riferita allo scenario n.58):

Quale/i esame/i va/vanno consigliato/i in prima istanza?

- ☒ A: Valutazione allergologica ed endoscopia nasale
- ☐ B: RM massiccio facciale con mezzo di contrasto
- ☐ C: TC massiccio facciale senza mezzo di contrasto
- ☐ D: Valutazione pneumologica, valutazione allergologica e TC massiccio facciale
- ☐ E: Valutazione allergologica e TC massiccio facciale

Domanda 114: (codice domanda: ssm2017225) - (riferita allo scenario n.58):

Quale trattamento è opportuno consigliare?

- ☒ A: Lavaggi nasali con soluzione fisiologica, terapia antistaminica per os, spray cortisonico nasale
- ☐ B: Lavaggi nasali con soluzione fisiologica e terapia antibiotica per os
- ☐ C: Terapia antibiotica e steroidea per os
- ☐ D: Lavaggi nasali con soluzione fisiologica, FANS per os al bisogno
- ☐ E: Aerosolterapia con beclometasone dipropionato e soluzione ipertonica al 3%

Scenario 59:

Una ragazza di 25 anni viene condotta in Pronto Soccorso per cefalea intermittente, crampi addominali, diarrea, arrossamento cutaneo al volto e cardiopalmo. La sintomatologia è insorta improvvisamente, poco dopo un pasto abbondante a base di pesce a un banchetto di strada vicino al porto. Viene posta diagnosi di sindrome sgombroide.

Domanda 115: (codice domanda: ssm2017229) - (riferita allo scenario n.59):

Qual è l'eziologia di tale patologia?

- ☒ A: Una reazione all'istamina, prodotta in grande quantità nella decomposizione del pesce mal conservato
- ☐ B: Un'infezione intestinale da *Morganella morganii*, contratta dal pesce infetto
- ☐ C: Un'intossicazione da mercurio, accumulato dal pesce cresciuto in acque contaminate
- ☐ D: Un'intossicazione acuta da idrocarburi alifatici, avvenuta per contaminazione del cibo con le acque inquinate del porto
- ☐ E: Un avvelenamento acuto con il veleno cutaneo del polpo *Hapalochlaena lunulata*, pescato assieme al pesce commestibile

Domanda 116: (codice domanda: ssm2017230) - (riferita allo scenario n.59):

Su quale classe di farmaci si basa la terapia?

- ☒ A: Antistaminici
- ☐ B: Oppioidi
- ☐ C: FANS
- ☐ D: Antibiotici
- ☐ E: Antivirali

Domanda 117: (codice domanda: ssm2017233) :

Quale delle seguenti affermazioni, per quanto riguarda la bassa statura familiare, è ERRATA?

- ☒ A: La velocità di crescita è ridotta
- ☐ B: L'età ossea è sovrapponibile a quella cronologica
- ☐ C: La statura definitiva è in linea con il percentile del bersaglio genetico
- ☐ D: I valori antropometrici alla nascita sono adeguati all'età gestazionale
- ☐ E: Lo sviluppo puberale è regolare

Scenario 60:

Viene in visita una bambina di 5 anni, che ha iniziato a manifestare faringodinia, febbre, cefalea, vomito, dolore addominale con micropetecchie al palato molle, con tonsille iperemiche coperte da essudato biancastro e linfadenite laterocervicale. La lingua ha aspetto a "fragola bianca".

Domanda 118: (codice domanda: ssm2017234) - (riferita allo scenario n.60):

In riferimento al caso clinico descritto, qual è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Scarlattina
- ☐ B: Mononucleosi
- ☐ C: Eritema polimorfo
- ☐ D: Malattia di Kawasaki
- ☐ E: Megaloeritema infettivo

Domanda 119: (codice domanda: ssm2017235) - (riferita allo scenario n.60):

Qual è la terapia di prima scelta?

- ☒ A: Amoxicillina
- ☐ B: Clindamicina
- ☐ C: Amikacina
- ☐ D: Ciprofloxacina
- ☐ E: Metronidazolo

Scenario 61:

Bambino di 6 anni, caucasico, nato a termine dopo gravidanza decorsa regolarmente. Peso e lunghezza alla nascita adeguati per l'età gestazionale. Periodo neonatale normodecorso. Allattamento materno per 7 mesi, divezzamento regolare. Buona salute generale. Al controllo periodico peso e altezza risultano al 3° percentile. Prepubere. Target genetico 3° percentile. Sviluppo somatico armonico. Sviluppo neurologico adeguato per l'età.

Domanda 120: (codice domanda: ssm2017236) - (riferita allo scenario n.61):

Quali sono gli accertamenti di primo livello da fare in un bambino di 6 anni di bassa statura?

- ☒ A: Esami ematici (emocromo, sierologia per celiachia, TSH, fT4, creatininemia e IGF 1) e radiografia del polso
- ☐ B: Radiografia comparata degli arti superiori e del polso
- ☐ C: Ecografia addome e radiografia del polso
- ☐ D: RM encefalo e radiografia del polso
- ☐ E: Test di stimolo per secrezione di GH e radiografia del polso

Scenario 62:

Bambina di 18 mesi, giunge in Pronto Soccorso per caduta accidentale dal divano di casa, in seguito alla quale ha riportato trauma temporale sinistro, senza perdita di coscienza. All'arrivo in PS la bambina si presenta in buone condizioni generali, vispa, reattiva e neurologicamente indenne. All'esame clinico si evidenzia solo un ematoma sottogaleale in sede di trauma.

Domanda 121: (codice domanda: ssm2017237) - (riferita allo scenario n.62):

Quale dei seguenti segni/sintomi NON è compatibile con un trauma cranico minore?

- ☒ A: Alterazione dello stato di coscienza
- ☐ B: Assenza di deficit della motilità oculare estrinseca
- ☐ C: Normale stato di coscienza
- ☐ D: Dolenzia in sede di trauma
- ☐ E: Assenza di segni neurologici focali

Domanda 122: (codice domanda: ssm2017238) - (riferita allo scenario n.62):

In caso di comparsa di sintomi neurologici, quale dei seguenti esami è il più indicato?

- ☒ A: TC encefalo
- ☐ B: RX cranio
- ☐ C: Esami ematici
- ☐ D: Elettroencefalogramma
- ☐ E: RM encefalo

Scenario 63:

Bambino di cinque mesi, unicogenito nato a termine, dopo gravidanza normodecorsa. Crescita regolare. Allattamento materno. Non problemi perinatali. Da qualche giorno presenta febbre (39 °C), inappetenza e qualche episodio di vomito. Il pediatra prescrive un'urinocoltura.

Domanda 123: (codice domanda: ssm2017239) - (riferita allo scenario n.63):

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

- ☒ A: L'urinocoltura da sacchetto è la metodica più affidabile per l'esame colturale delle urine
- ☐ B: La metodica più affidabile per eseguire l'urinocoltura è il cateterismo vescicale
- ☐ C: Nel lattante febbrile con sospetta infezione delle vie urinarie è necessario fare l'emocoltura su puntata febbrile
- ☐ D: Gli esami ematici per la valutazione degli indici di flogosi sono indicati in caso di sospetto stato settico
- ☐ E: Un'infezione delle vie urinarie può essere segno di una malformazione del tratto genito-urinario

Domanda 124: (codice domanda: ssm2017240) - (riferita allo scenario n.63):

In caso di urinocoltura positiva, la terapia antibiotica deve essere somministrata per via parenterale:

- ☒ A: solo nelle forme complicate, con stato settico del paziente
- ☐ B: sempre
- ☐ C: solo nei maschi di età inferiore ai due anni
- ☐ D: non appena ottenuto l'esito dell'antibiogramma
- ☐ E: solo nelle infezioni da Escherichia coli

Scenario 64:

Uomo di 35 anni, seguito dai servizi territoriali da 10 anni, giunge in Pronto Soccorso accompagnato dai genitori per riacutizzazione da circa una settimana del quadro clinico con comparsa di ritiro sociale, anoressia, delirio di tipo persecutorio incentrato sui colleghi, dispercezioni uditive di tipo imperativo. La mimica appare fatua, dissintona, eloquio da stimolare, tono dell'umore appiattito. Il sonno viene descritto come regolare.

Domanda 125: (codice domanda: ssm2017249) - (riferita allo scenario n.64):

Qual è la diagnosi più plausibile?

- ☒ A: Schizofrenia
- ☐ B: Disturbo di personalità schizoide
- ☐ C: Episodio maniacale
- ☐ D: Anoressia nervosa
- ☐ E: Episodio depressivo maggiore

Domanda 126: (codice domanda: ssm2017250) - (riferita allo scenario n.64):

Quale trattamento risulta indicato?

- ☒ A: Antipsicotico
- ☐ B: Stabilizzante del tono dell'umore
- ☐ C: Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
- ☐ D: Benzodiazepine
- ☐ E: Antidepressivi Triciclici

Domanda 127: (codice domanda: ssm2017251) - (riferita allo scenario n.64):

Nel caso di scarsa aderenza ai trattamenti farmacologici orali, quale strategia terapeutica è più opportuna per la prevenzione delle ricadute?

- ☒ A: Terapia con farmaci antipsicotici long-acting
- ☐ B: Counseling psicologico
- ☐ C: Terapia occupazionale
- ☐ D: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
- ☐ E: Riabilitazione cognitiva

Domanda 128: (codice domanda: ssm2017254) :

Qual è l'aspetto radiologico caratteristico dell'ileo meccanico?

- ☒ A: Presenza di livelli idro-aerei disposti a diversa altezza
- ☐ B: Assenza di livelli idroaerei
- ☐ C: Aria in ampolla rettale
- ☐ D: Distensione della cornice colica
- ☐ E: Liquido in ampolla rettale

Scenario 65:

Un uomo di 60 anni accede in Pronto Soccorso in seguito all'insorgenza di dispnea e tachipnea. Tra gli esami ematochimici il dato saliente è un valore di D-dimero plasmatico intorno agli 800 ng/mL.

Domanda 129: (codice domanda: ssm2017255) - (riferita allo scenario n.65):

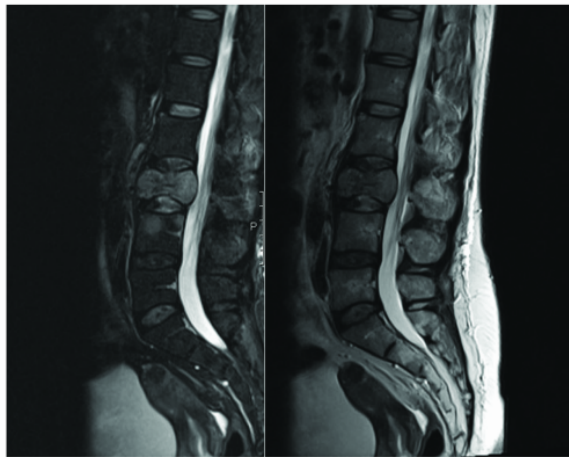
Quale tra i seguenti reperti TC è il più suggestivo di una tromboembolia polmonare?

- ☒ A: Difetto di opacizzazione di una parte o di tutto un vaso arterioso polmonare
- ☐ B: La presenza di plurimi noduli calcifici polmonari
- ☐ C: La mancata opacizzazione di porzioni di aorta ascendente e discendente
- ☐ D: La presenza di una soluzione di continuo nella parete dell'arco aortico
- ☐ E: Una incrementata opacizzazione dei vasi arteriosi polmonari da parte del mezzo di contrasto

Scenario 66:

Paziente di 45 anni esegue indagine Risonanza Magnetica della colonna lombare per lombalgia da 2 mesi non responsiva ai farmaci antinfiammatori.

Domanda 130: (codice domanda: ssm2017256) - (riferita allo scenario n.66):



L'immagine mostra una RM del rachide lombare su quale dei tre piani anatomici?

- ☒ A: Piano sagittale puro
- ☐ B: Piano coronale puro
- ☐ C: Piano assiale puro
- ☐ D: Piano sagittale obliquo per lo studio dei forami di coniugazione
- ☐ E: Piano sagittale obliquo per lo studio dei peduncoli

Domanda 131: (codice domanda: ssm2017257) - (riferita allo scenario n.66):

Nella RM si rileva una probabile metastasi ossea. Quale indagine è la più appropriata per identificare la presenza di metastasi ossee?

- ☒ A: Scintigrafia ossea
- ☐ B: TC con protocollo a bassa dose di tutto lo scheletro
- ☐ C: TC del rachide in toto
- ☐ D: Esame ecografico selettivo delle regioni scheletriche sospette
- ☐ E: TC dello scheletro in toto con mezzo di contrasto

Scenario 67:

Paziente di 45 anni sottoposta a quadrantectomia per carcinoma duttale della mammella sinistra, pT1cpN0 con recettori ormonali positivi. Le viene prescritta terapia ormonale e viene avviata a radioterapia.

Domanda 132: (codice domanda: ssm2017263) - (riferita allo scenario n.67):

Quale, tra i seguenti, è lo scopo del trattamento radioterapico in questa paziente?

- ☒ A: Adiuvante
- ☐ B: Neo-adiuvante
- ☐ C: Palliativo
- ☐ D: Radicale
- ☐ E: Citoriduttivo

Domanda 133: (codice domanda: ssm2017265) :

Quale delle seguenti alterazioni endocrinologiche è più frequentemente associata all'artropatia da deposizione di cristalli di pirofosfato di calcio?

- ☒ A: Iperparatiroidismo primario
- ☐ B: Ipotiroidismo
- ☐ C: Sindrome di Cushing
- ☐ D: Iperprolattinemia
- ☐ E: Diabete mellito tipo I

Scenario 68:

Un uomo di 56 anni giunge all'attenzione medica riferendo comparsa nella notte di intenso dolore a livello del ginocchio destro. Ha assunto paracetamolo 1 grammo, con scarso beneficio. Si sospetta artropatia da cristalli.

Domanda 134: (codice domanda: ssm2017266) - (riferita allo scenario n.68):

Quale dei seguenti approcci consente una diagnosi di certezza di artropatia da cristalli?

- ☒ A: Artrocentesi
- ☐ B: Dosaggio uricemia
- ☐ C: Ecografia articolare
- ☐ D: Radiogramma standard
- ☐ E: Terapia ex iuvantibus con indometacina

Domanda 135: (codice domanda: ssm2017267) - (riferita allo scenario n.68):

Si pone diagnosi di artrite gottosa e viene avviata un'appropriata terapia. Dopo 3 giorni di terapia il paziente riferisce comparsa di importante diarrea. Quale dei seguenti farmaci comunemente utilizzati nella terapia dell'artrite gottosa si associa più comunemente a tale effetto collaterale?

- ☒ A: Colchicina
- ☐ B: Naprossene
- ☐ C: Prednisone
- ☐ D: Inibitore dell'interleuchina 1
- ☐ E: Allopurinolo

Scenario 69:



Una donna di 19 anni presenta addominalgia e diarrea postprandiali ed esegue una esofagogastroduodenoscopia nel sospetto di un malassorbimento.

Domanda 136: (codice domanda: ssm2017271) - (riferita allo scenario n.69):

Che cosa si può dedurre dall'immagine?

- ☒ A: È presente una atrofia della mucosa
- ☐ B: È presente un'ulcera della mucosa
- ☐ C: È presente una neoformazione
- ☐ D: È presente sanguinamento della mucosa
- ☐ E: Sono presenti fistole e ascessi

Scenario 70:

Il ministero della Sanità sta cercando di organizzare un test di screening per la diagnosi precoce di una patologia neoplastica.

Domanda 137: (codice domanda: ssm2017273) - (riferita allo scenario n.70):

Uno dei test di screening ha una sensibilità del 90%. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☒ A: È atteso un 10% di falsi negativi
- ☐ B: È atteso un 10% di falsi positivi
- ☐ C: È atteso un 90% di veri negativi
- ☐ D: È atteso un 90% di falsi positivi
- ☐ E: È atteso un 10% di veri negativi

Scenario 71:

Una donna di 36 anni si reca in Pronto Soccorso lamentando un forte dolore al fianco sinistro, irradiato all'inguine. In sala di attesa comincia ad avere brividi e febbre.

Domanda 138: (codice domanda: ssm2017275) - (riferita allo scenario n.71):

Qual è l'iter diagnostico più appropriato?

- ☒ A: Esami ematochimici ed ecografia addome
- ☐ B: Valutazione anestesiológica urgente
- ☐ C: Esami ematochimici e TC addome
- ☐ D: Ecografia trans-vaginale, esami ematochimici e TC addome
- ☐ E: Antibioticoterapia e ricovero in osservazione

Domanda 139: (codice domanda: ssm2017276) - (riferita allo scenario n.71):

Quale tipo di calcoli NON è visibile a un RX addome?

- ☒ A: Acido urico
- ☐ B: Ossalato di calcio
- ☐ C: Idrossiapatite
- ☐ D: Cistina
- ☐ E: Xantina

Domanda 140: (codice domanda: ssm2017277) - (riferita allo scenario n.71):

Quale farmaco può essere utile nell'espulsione di litiasi prevescicale?

- ☒ A: Alpha-litico
- ☐ B: Cortisone
- ☐ C: Anti-muscarinico
- ☐ D: Inibitore delle 5-alfariduttasi (5-ARI)
- ☐ E: Inibitore delle fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5)